

FACULTE DE MEDECINE DE SOUSSE

CONCOURS DE RESIDANAT 2025

Infections Respiratoires Basses

(Evaluation)

Bellazreg

Pr

Foued

Pr Imen Gargouri

QCM

1. Les signes cliniques suivants peuvent être observés lors de la phase initiale de la bronchite aiguë :

- A- douleur thoracique à type de point côté
- B- catarrhe nasale
- C- fièvre
- D- odynophagie
- E- toux productive

2. Chez un patient ayant une bronchite aiguë :

- A- une radiographie de thorax doit être réalisée systématiquement
- B- La radiographie de thorax est souvent normale
- C- L'examen cytbactériologique de crachats doit être réalisé
- D- l'évolution est souvent favorable en 10 à 15 jours
- E- une toux sèche peut persister plusieurs semaines

3. Les virus les plus fréquemment responsables de bronchite aiguë chez l'enfant sont :

- A- adénovirus
- B- rhinovirus
- C- virus de la grippe
- D- virus *parainfluenza*
- E- virus respiratoire syncytial

4. Les bactéries responsables de bronchite aiguë bactérienne sont :

- A- *Chlamydia pneumoniae*
- B- *Haemophilus influenzae*
- C- *Mycoplasma pneumoniae*
- D- *Staphylococcus aureus*
- E- *Streptococcus pneumoniae*

5. Les pneumonies aiguës communautaires (PAC) sont :

- A- acquises à l'hôpital
- B- confirmées par la radiographie de thorax
- C- d'origine bactérienne ou virale
- D- plus fréquentes que les bronchites aiguës
- E- la première cause de décès par infection dans le monde

6. Les facteurs suivants favorisent la survenue d'une PAC :

- A- âge jeune
- B- dénutrition
- C- fausses routes
- D- hypertension artérielle
- E- immunodépression

7. Au cours de la PAC, la voie de contamination la plus fréquente est :

- A- contigüité
- B- hématogène
- C- inhalation
- D- inoculation directe
- E- lymphatique

8. Les signes cliniques d'une pneumonie lobaire aiguë sont :

- A- douleur thoracique à type de brûlures rétrosternales
- B- fièvre d'installation brutale
- C- râles crépitants
- D- souffle tubaire
- E- toux avec expectoration purulente

9. Pour le diagnostic d'une PAC :

- A- la radiographie de thorax est l'examen de référence
- B- l'échographie pleuro-pulmonaire est un examen de routine
- C- le scanner thoracique est indiqué en cas de doute diagnostique
- D- un bilan biologique est systématique en cas de prise en charge ambulatoire
- E- la gazométrie artérielle est systématique

10. Le taux de positivité des hémocultures au cours des PAC est de :

- A- 1%
- B- 5%%
- C- 10%
- D- 20%
- E- 30%

11. Les signes de gravité d'une PAC sont :

- A- fréquence cardiaque à 100 b/min
- B- fréquence respiratoire à 32 c/min
- C- somnolence
- D- SpO2 à 94%
- E- tension artérielle à 80/40 mm Hg

12. Les signes de gravité d'une PAC sont :

- A- atteinte alvéolaire
- B- atteinte bilobaire

- C- atteinte interstitielle
- D- extension rapide des lésions
- E- opacité excavée

13. Les pneumonies atypiques sont caractérisées par :

- A- atteinte interstitielle
- B- début brutal
- C- fièvre modérée
- D- syndrome grippal
- E- toux sèche

14. Les pneumonies à staphylocoque sont caractérisées par :

- A- atteinte bilatérale
- B- gravité
- C- images bulleuses
- D- porte d'entrée respiratoire
- E- pyopneumothorax

15. Les pneumonies à *Mycoplasma pneumoniae* sont caractérisées par :

- A- anémie hémolytique
- B- début progressif
- C- diagnostic par hémocultures
- D- survenue chez l'adulte jeune
- E- survenue par petites épidémies

16. Chez un patient ayant une pneumonie aigue communautaire (PAC), vous évoquez *Legionella pneumophila* devant :

- A- cytolysé hépatique
- B- signes digestifs
- C- signes neurologiques
- D- opacité alvéolaire systématisée
- E- utilisation du climatiseur

17. Une pneumonie avec haleine fétide chez un patient ayant des caries dentaires évoque l'étiologie suivante :

- A- anaérobies
- B- grippe
- C- *Klebsiella*
- D- *Legionella*
- E- pneumocoque

18. La pneumonie chez le sujet âgé est caractérisée par :

- A- des signes respiratoires au premier plan
- B- fréquence de l'origine pneumococcique
- C- fréquence des bacilles à Gram négatif
- D- bon pronostic
- E- tableau clinique typique

19. Chez un patient atteint de PAC, les facteurs de risque d'infection par un pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline sont :

- A- âge à 60 ans
- B- acquisition nosocomiale de la pneumonie
- C- hospitalisation 12 mois avant la pneumonie
- D- infection par le VIH
- E- traitement par céfixime 2 mois avant la pneumonie

20. L'amoxicilline-acide clavulanique est actif sur les bactéries suivantes :

- A- Anaérobies
- B- *Chlamydia pneumoniae*
- C- *Haemophilus influenzae*
- D- *Legionella pneumophila*
- E- *Streptococcus pneumoniae*

21. L'azithromycine est active sur les bactéries suivantes :

- A- *Chlamydia pneumoniae*
- B- *Haemophilus influenzae*
- C- *Legionella pneumophila*
- D- *Mycoplasma pneumoniae*
- E- *Streptococcus pneumoniae*

22. Les antibiotiques suivants sont actifs sur le pneumocoque :

- A- amoxicilline
- B- amoxicilline - acide clavulanique
- C- céfotaxime
- D- ciprofloxacine
- E- lévofloxacine

23. Les antibiotiques suivants sont actifs sur *Mycoplasma pneumoniae* :

- A- amoxicilline - acide clavulanique
- B- clarithromycine
- C- doxycycline
- D- lévofloxacine
- E- pristinamycine

24. Les critères d'hospitalisation en Réanimation d'un patient atteint de PAC sont :

- A- acidose sévère

- B- atteinte multilobaire
- C- fréquence respiratoire à 26 c/min
- D- progression des lésions radiologiques > 50% en 48 heures
- E- tension artérielle à 100/60 mm Hg

25. Les indications de la vaccination anti-pneumococcique sont :

- A- drépanocytose
- B- fibrose pulmonaire
- C- hypertension artérielle
- D- traitement immunosuppresseur
- E- insuffisance cardiaque

26. L'antibiothérapie de 1^{ère} intention d'une PAC alvéolaire sans signe de gravité chez un patient âgé de 30 ans, sans comorbidité est :

- A- amoxicilline
- B- amoxicilline - acide clavulanique
- C- clarithromycine
- D- ciprofloxacine
- E- lévofloxacine

27. L'antibiothérapie de 1^{ère} intention d'une PAC alvéolaire sans signe de gravité chez un patient âgé de 50 ans, suivi pour myélome multiple est :

- A- amoxicilline
- B- amoxicilline - acide clavulanique
- C- céfixime
- D- ciprofloxacine
- E- clarithromycine

28. L'antibiothérapie de 1^{ère} intention d'une PAC chez un patient hospitalisé en Réanimation comporte les antibiotiques suivants :

- A- amoxicilline-acide clavulanique
- B- céfotaxime
- C- cotrimoxazole
- D- doxycycline
- E- lévofloxacine

29. Le traitement antiviral à prescrire chez un patient atteint de pneumonie grippale est :

- A- bocéprévir
- B- cidofovir
- C- entécavir
- D- oseltamivir
- E- ténofovir

30. Chez un patient ayant une PAC, une fibroscopie bronchique doit être réalisée dans les situations suivantes :

- A- opacité rétractile à la radiographie de thorax
- B- pneumopathie excavée
- C- pneumopathie interstitielle
- D- pneumopathie récidivante dans le même territoire
- E- pneumopathie trainante dans le même territoire

Cas clinique 1 :

Une patiente âgée de 20 ans, sans antécédents pathologiques, consulte pour fièvre d'installation progressive avec céphalées, et toux sèche évoluant depuis 10 jours. L'examen était normal hormis une fièvre à 38°C. La radiographie de thorax avait montré un syndrome interstitiel bilatéral. Bilan biologique : GB 3500/mm³, Plaquettes 200000, Hb 10 ; ALAT 80, ASAT 60.

1- Quel est le premier diagnostic à évoquer :

- A- abcès du poumon
- B- bronchite aiguë
- C- bronchiolite aiguë
- D- pneumonie alvéolaire
- E- pneumonie atypique

2- Les bactéries qui peuvent être responsables de cette infection sont :

- A- *Chlamydia pneumoniae*
- B- *Haemophilus influenzae*
- C- *Klebsiella pneumoniae*
- D- *Mycoplasma pneumoniae*
- E- *Streptococcus pneumoniae*

3- Les antibiotiques suivants peuvent être prescrits chez cette patiente :

- A- amoxicilline
- B- amoxicilline - acide clavulanique
- C- azithromycine
- D- clarithromycine
- E- cotrimoxazole

4- La durée totale de l'antibiothérapie est de :

- A- 3 jours
- B- 5 jours
- C- 14 jours
- D- 21 jours
- E- 28 jours

5- En pratique courante, le diagnostic bactériologique de cette pneumonie peut se faire par :

- A- antigénurie
- B- ECBC avec examen direct et culture
- C- hémocultures
- D- PCR sur écouvillonnage nasopharyngé
- E- sérologie

Cas clinique 2 :

Un patient âgé de 60 ans, suivi pour myélome multiple, consulte pour toux avec fièvre à 39°C et douleur thoracique d'installation brutale depuis 24 heures. Examen : conscient, bien orienté. TA 13/7, pouls 100 b/min. FR 24 c/min. râles crépitants au niveau de l'apex pulmonaire droite. Radio thorax : opacité alvéolaire basale droite non excavée. créatinine 70 $\mu\text{mol/L}$, urée 6 mmol/L, GB 15000, PNN 12000, plaquettes 200000, Hb 15.

1- Quel diagnostic évoquez-vous en premier ?

- A- abcès du poumon
- B- bronchite aiguë
- C- bronchiolite aiguë
- D- pneumonie alvéolaire
- E- pneumonie atypique

2- Quelle bactérie responsable de cette infection évoquez-vous en premier ?

- A- *Chlamydia pneumoniae*
- B- *Haemophilus influenzae*
- C- *Klebsiella pneumoniae*
- D- *Mycoplasma pneumoniae*
- E- *Streptococcus pneumoniae*

3- Les antibiotiques suivants peuvent être prescrits chez ce patient :

- A- amoxicilline - acide clavulanique
- B- céfixime
- C- ceftriaxone
- D- ciprofloxacine
- E- ofloxacine

4- L'examen complémentaire suivant peut être demandé pour le diagnostic bactériologique :

- A- hémocultures
- B- lavage bronchoalvéolaire
- C- PCR sur écouvillonnage nasopharyngé
- D- sérologie *Chlamydia*
- E- sérologie *Mycoplasma*

Cas clinique 3 :

Un patient âgé de 70 ans, sous corticothérapie depuis 2 mois pour maladie de Horton, a été amené par sa famille pour dyspnée et désorientation temporo-spatiale survenues depuis quelques heures. L'interrogatoire trouve la notion de toux sèche avec arthromyalgies et asthénie il y a 10 jours et une fièvre avec dyspnée d'aggravation progressive depuis 24 heures. Examen : patient confus, T° 39°C, FR 35 c/min, tirage intercostal et sus-sternal, TA 80/40 mm Hg, FC 130, SpO2 84% à l'air ambiant, 94% sous O2 10L/min. Radio thorax : syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral diffus. Le patient a été hospitalisé au service de Réanimation Médicale.

1- Les signes de gravité chez ce patient sont :

- A- confusion
- B- fièvre
- C- fréquence cardiaque à 130 b/min
- D- fréquence respiratoire à 35 c/min
- E- tension artérielle à 80/40 mm Hg

2- Les microorganismes suivants peuvent être responsables de cette pneumopathie ?

- A- *Acinetobacter baumannii*
- B- *Haemophilus influenzae*
- C- *Legionella pneumophila*
- D- *Streptococcus pneumoniae*
- E- virus *Influenza*

3- L'antibiothérapie à prescrire en 1^{ère} intention comporte les antibiotiques suivants :

- A- amoxicilline-acide clavulanique
- B- céfotaxime
- C- cotrimoxazole
- D- doxycycline
- E- lévofloxacine

4- Les examens complémentaires suivants peuvent être réalisés à visée étiologique :

- A- antigénurie pneumocoque
- B- antigénurie *Legionella*
- C- hémocultures
- D- lavage bronchoalvéolaire
- E- PCR grippe

Le patient a été traité. L'évolution était favorable.

5- La durée totale de l'antibiothérapie est de :

- A- 5 jours
- B- 7 jours
- C- 10 jours

D- 21 jours

E- 28 jours